



TIBBIY DIAGNOSTIKA XULOSASI

EKG TAHLILI NATIJALARI

BEMOR MA'LUMOTLARI

Familiya, ism, sharif:	ISMOILOV RAHMONJON ZOHID O'G'LI
Tug'ilgan sana:	18.03.2001 (25 yosh)
Jinsi:	Erkak
Passport:	** ****7391
Manzil:	IMOM BUXORIY MAHALLASI, IBN SINO KO'CHASI 7 UY
Telefon:	998917984232

TAHLIL MA'LUMOTLARI

Tahlil sanasi:	24.04.2026 19:00
Tahlil turi:	EKG (Elektrokardiografiya)
Uskuna:	AI yordamida avtomatik tahlil
Kiritgan xodim:	ISMOILOV RAHMONJON ZOHID O'G'LI
Davolovchi shifokor(lar):	AMRULLAYEV A. U., DAVLATOV A. I.
Shikoyatlar:	Bosh aylanishi va hushdan ketish (Dizziness / Syncope), Kechasi nafas yetmay uyg'onish (paroxysmal nocturnal dyspnoea), Ko'krakda parietal og'riq (oldinga egilganda yengillashuvchi), Yo'tal (ayniqsa yotganda kuchayadigan)

TAHLIL NATIJALARI

Parametr	Qiymat	Norma	Baho
Yurak urish tezligi	54 bpm, patologik (sinus bradikardiya) bpm	60–100	—
PR interval	160 ms, normal (AV o'tkazuvchanlik saqlangan) ms	120–200	—
QRS davomiyligi	102 ms, normal chegarada (tor QRS) ms	60–120	—
QT interval	458 ms, uzayishga moyil (HR past bo'lgani uchun QT nisbatan uzun ko'rinadi) ms	350–450	—
QTc (Bazett)	436 ms, chegaraviy/engil uzaygan (erkak uchun) ms	< 440 (erkak)	—

SUN'IY INTELLEKT TAHLILI XULOSASI

EKGda sinus bradikardiya (HR 54 bpm) va QTc Bazett bo'yicha chegaraviy uzayish (436 ms). O'tkir ishemiyaga xos ishonchli ST elevatsiya/depressiya ko'rinmadi. Klinik shikoyatlar (hushdan ketish, PND, yotganda kuchayadigan yo'tal, oldinga egilganda yengillashadigan ko'krak og'rigi) EKGdan qat'i nazar perikardit/plevrit, perikardial effuziya yoki yurak yetishmovchiligi kabi holatlarni istisno qilishni talab qiladi; sincope/bradikardiya esa Holter va elektrofiziologik baholashni talab qiladi.

Jiddiylik darajasi:

OG'IR (3/3)

Shifokorga tavsiyalar:

- Zudlik bilan kardiolog (zarurat bo'lsa shoshilinch yordam)ga murojaat qiling, ayniqsa qayta hushdan ketish, kuchli hansirash yoki ko'krak og'rig'i davom etsa. Qo'shimcha tekshiruvlar: 24–48 soatlik Holter EKG (bradikardiya pauzalari/AV blok/aritmia uchun), EHO-KG (perikardial suyuqlik, chap qorincha funksiyasi, qopqoq nuqsonlari), troponin va yallig'lanish markerlari (CRP/ESR) klinikaga ko'ra, elektrolitlar (K, Mg, Ca) va TSH (QT/ritmga ta'siri uchun), ko'krak qafasi rentgen/KT shifokor ko'rsatmasi bilan. Jismoniy faollik: hushdan ketish xavfi sabab intensiv sport va og'ir jismoniy zo'riqishlarni vaqtincha to'xtating, yolg'iz suzish/avtomobil haydashdan saqlaning. Davolash yo'nalishi tashxisga bog'liq: simptomatik sinus bradikardiya sabablarni (dori, elektrolit, qalqonsimon bez) tuzatish; perikardit gumonida shifokor nazoratida yallig'lanishga qarshi davolash; yurak yetishmovchiligi tasdiqlansa standart HF terapiyasi va sababini aniqlash.

Yakuniy xulosa:

EKG: sinus ritm, sinus bradikardiya (54 bpm), PR 160 ms va QRS 102 ms (normal), QTc Bazett 436 ms (chegaraviy uzayish). O'tkir ishemiya uchun ishonchli ST o'zgarishlari ko'rinmadi. Biroq bemordagi sincope + PND + yotganda kuchayadigan yo'tal va oldinga egilganda yengillashadigan ko'krak og'rig'i jiddiy yurak/perikard patologiyasini istisno qilishni talab qiladi; shoshilinch kardiologik baholash, Holter va EHO-KG tavsiya etiladi.



NMED platformasi orqali rasman tasdiqlangan

Hujjat raqami: NMED-EKG-00001919

Tasdiqlangan: 25.04.2026 04:01

nmed.uz

DIQQAT: Ushbu xulosa sun'iy intellekt tomonidan shakllantirilgan va shifokor xulosasini **ALMASHTIRMAYDI**. Yakuniy tashxis faqat malakali shifokor tomonidan qo'yiladi.